HOLISTICA DOC

ШКОЛА ПРАКТИЧЕСКОЙ НУТРИЦИОЛОГИИ

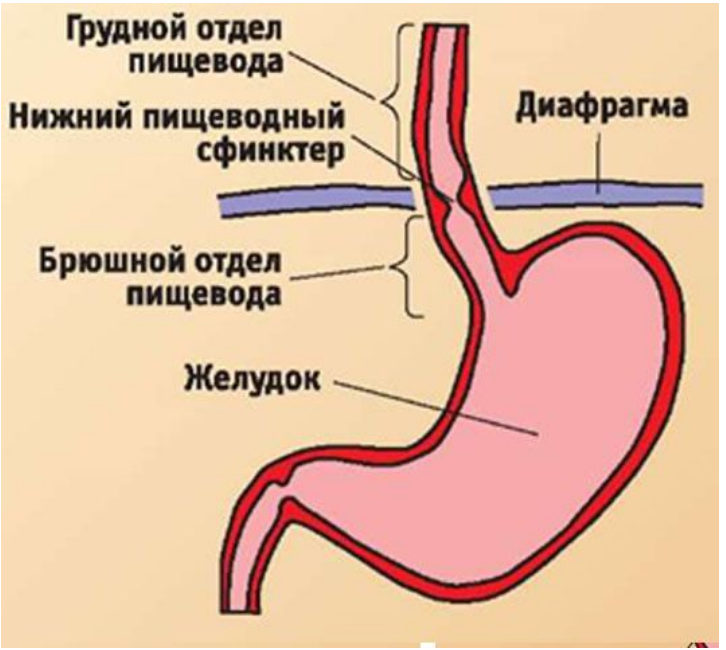
Учебно-практическая программа

ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ ЖКТ



Изжога, рефлюкс, ГЭРБ - часть 1

Изжога и рефлюкс - что это и почему появляются?



HOLISTICA DOC

Изжога

- жжение в пищеводе,
- кислый / горький привкус во рту,
- отрыжка,
- ощущение заброса кислоты / горечи в горло,
- боль за грудиной в области пищевода.



Как правило возникает **после еды, при наклонах и в положении лежа.**

Изжогу вызывает ***рефлюкс*** - попадание желудочного содержимого в пищевод.

Физиологический (нормальный) рефлюкс

есть у всех здоровых людей.

В норме - вообще никак не ощущается (нет изжоги). Чаще возникает после еды, длится недолго (3–5 минут).

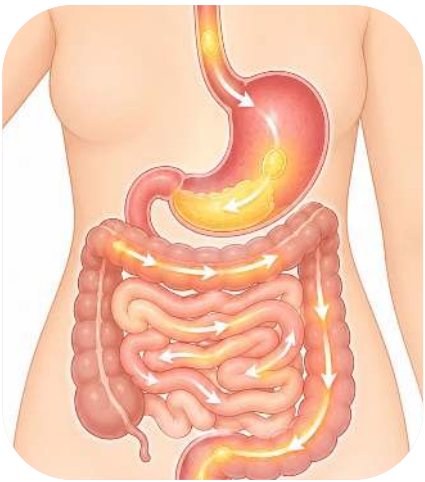
Не вызывает **воспаления и повреждения слизистой.**

Быстро устраняется естественными защитными механизмами организма.



В норме пища движется сверху вниз благодаря:

- перистальтике;
- работе сфинктеров;
- разнице давления между отделами ЖКТ.



Организм защищают антирефлюксные механизмы: нижний пищеводный сфинктер, ножки диафрагмы, угол Гиса, нормальная перистальтика пищевода, очищение пищевода слюной, защита слизистой пищевода.

HOLISTICA DOC



HOLISTICA DOC

Рефлюкс есть у всех, но изжога - не у всех

Проблема возникает, если:

- изжога **становится частой;**
- эпизоды продолжаются **долго;**
- нарушаются **антирефлюксные механизмы;**
- **слизистая пищевода регулярно контактирует с агрессивным содержимым желудка** (соляная кислота, пепсин, желчные кислоты, содержимое двенадцатиперстной кишки)

Это может привести к **повреждению слизистой и развитию заболеваний пищевода**

Если изжога + отрыжка, боли и другие признаки рефлюкса возникают:

- **2+ раза** в неделю
- **Регулярно** - на протяжении 4–8 недель



Необходимо обследование **- может быть проявлением гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ).**

Что скрывается за изжогой?

1. **Функциональная изжога**
2. **Гиперсенситивный пищевод**
3. **ГЭРБ**

Кислоты в пищеводе слишком много. Изжога возникает именно когда кислота в пищеводе.



Чрезмерный рефлюкс (ГЭРБ)

Кислоты в пищеводе не больше, чем в норме. Но нервная система пищевода замечает и это.



Гиперчувствительный пищевод

Кислоты в пищеводе может и не быть. Но изжога почему-то ощущается.



Функциональная изжога

HOLISTICA DOC

Функциональная изжога

Пищевод не поврежден, воспаления нет, слизистая не повреждена, жалобы есть.

Изжога и боли в пищеводе могут быть даже тогда, когда **рефлюкса нет.**
Это расстройство, связанное с нарушением восприятия боли и обработки сигналов нервной системой.



Часто сочетается с другими функциональными заболеваниями ЖКТ:

- синдром раздраженного кишечника,
- функциональная диспепсия,
- функциональный запор,
- + тревожность, хронический стресс, нарушения сна.

HOLISTICA DOC

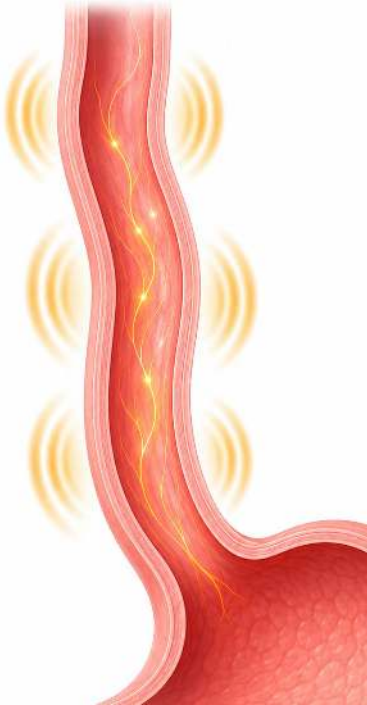
Гиперчувствительный пищевод

Пищевод не поврежден, воспаления нет, слизистая не повреждена, жалобы есть.

Рефлюкс есть, **но он физиологичный (нормальный).**

При этом у человека активные жалобы - на изжогу, жжение, боли и тд., как будто рефлюкс сильный.

Причина: избыточная чувствительность рецепторов пищевода, когда даже нормальны



HOLISTICA DOC

Гиперчувствительный пищевод

Основные механизмы появления избыточной чувствительности

- нарушение плотных межклеточных контактов и повышение проницаемости слизистой пищевода,
- **снижение порога чувствительности рецепторов +** усиление восприятия боли центральной нервной системой.



Функциональная изжога и гиперчувствительный пищевод - чаще всего встречаются у людей с **ЧУВСТВИТЕЛЬНЫМ** типом пищеварения (расстройство доша Ветер / Вата)

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ)

Хроническое заболевание, при котором рефлюкс становится патологическим: содержимое желудка, а иногда и двенадцатиперстной кишки, регулярно и длительно забрасывается в пищевод, вызывает жалобы и повреждает слизистую, вызывая воспаление



HOLISTICA DOC

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ)

У части людей есть дополнительно **дуоденогастральный рефлюкс** — заброс содержимого двенадцатиперстной кишки в желудок. Если затем происходит гастроэзофагеальный рефлюкс, в пищевод попадает смешанное содержимое желудка и кишечника, которое может быть особенно агрессивным.

ГЭРБ - **одно из самых распространенное хр. заболеваний органов ЖКТ.**
Симптомы ГЭРБ есть **у 10–20% взрослого** населения планеты. Риск ГЭРБ значимо увеличивается **после 40 лет.**



HOLISTICA DOC

Симптомы ГЭРБ

Изжога - ощущение жжения за грудиной, начинается в подложечной области и распространяется вверх к шее или горлу.



Чаще возникает: через 30–90 минут после еды, после переедания, при наклонах вперед, в положении лежа, ночью, после жирной пищи, алкоголя, кофе, шоколада и газированных напитков.
Сила изжоги не всегда отражает тяжесть заболевания.

Внимание! Тихий рефлюкс: *ГЭРБ протекает почти бессимптомно, эрозии и пищевод Баррета (пред онко) могут обнаружить на случайном обследовании при отсутствии жалоб.*

1. **Отрыжка** - воздухом, кислым содержимым, горечью
   Чаще возникает: после еды, переедания, употребления газированных напитков.

2. **Регургитация** - пассивный заброс желудочного содержимого в рот или глотку без тошноты и рвоты:
   кислый привкус;
   горечь во рту;
   ощущение, что пища или жидкость поднимаются обратно по пищеводу.

3. **Боль за грудиной**
   Может быть жгучая или давящая боль за грудиной, необходимо исключить заболевания сердца!

4. **Ком в горле или за грудиной**

5. **Ощущение затрудненного прохождения пищи по пищеводу** - требует обязательного обследования!(может быть признаком развития осложнений)

6. **Боль при глотании или прохождении пищи по пищеводу** - появляется при выраженном воспалении слизистой или эрозиях пищевода.

7. **Икота** - связана с раздражением диафрагмы или диафрагмального нерва при рефлюксе.

Внепищеводные симптомы (маски) ГЭРБ

ЛОР-маска

- першение и боль в горле;
- ком в горле;
- осиплость голоса;
- хроническое покашливание или кашель;
- неприятный запах изо рта.

Частые диагнозы: хронический фарингит, ларингит, тонзиллит, синусит.

Важно: если ЛОР-заболевания постоянно рецидивируют и плохо поддаются лечению, стоит исключить ГЭРБ.



Внепищеводные симптомы (маски) ГЭРБ

Лёгочная маска

- хронический кашель;
- ночной кашель;
- приступы удушья;
- одышку;
- свистящее дыхание;
- характерно усиление симптомов после еды, ночью и в положении лежа.

Возможные диагнозы:
бронхиальная астма (особенно если он начинается в позднем возрасте!), хронический бронхит.



Внепищеводные симптомы (маски) ГЭРБ

Сердечная маска

- чувство давления в груди;
- боль или жжение за грудиной;
- сердцебиение;
- ощущение перебоев в работе сердца.

Для рефлюксной боли характерно появление после еды, при наклонах и в положении лежа.

Важно: любые боли в груди требуют исключения сердечно-сосудистых заболеваний.

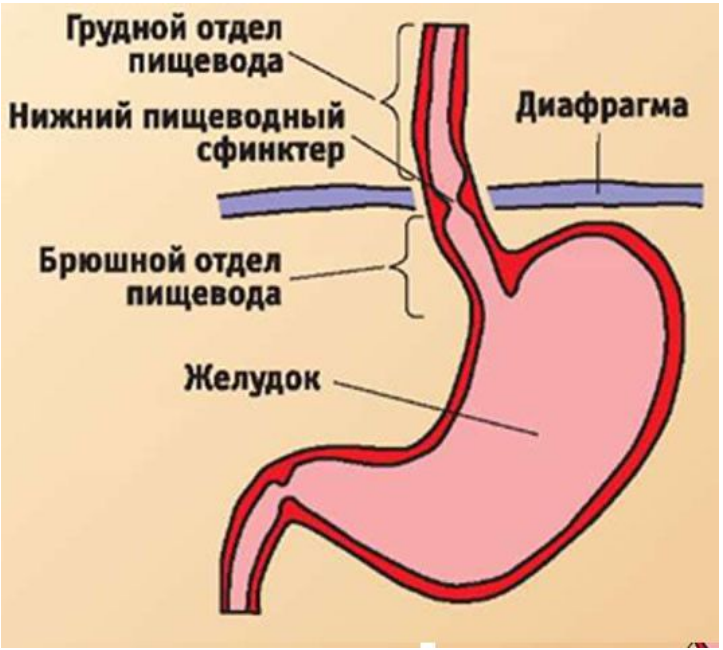


Внепищеводные симптомы (маски) ГЭРБ

Стоматологическая маска

- эрозия эмали;
- повышенная чувствительность зубов;
- кариес;
- стоматиты.





HOLISTICA DOC

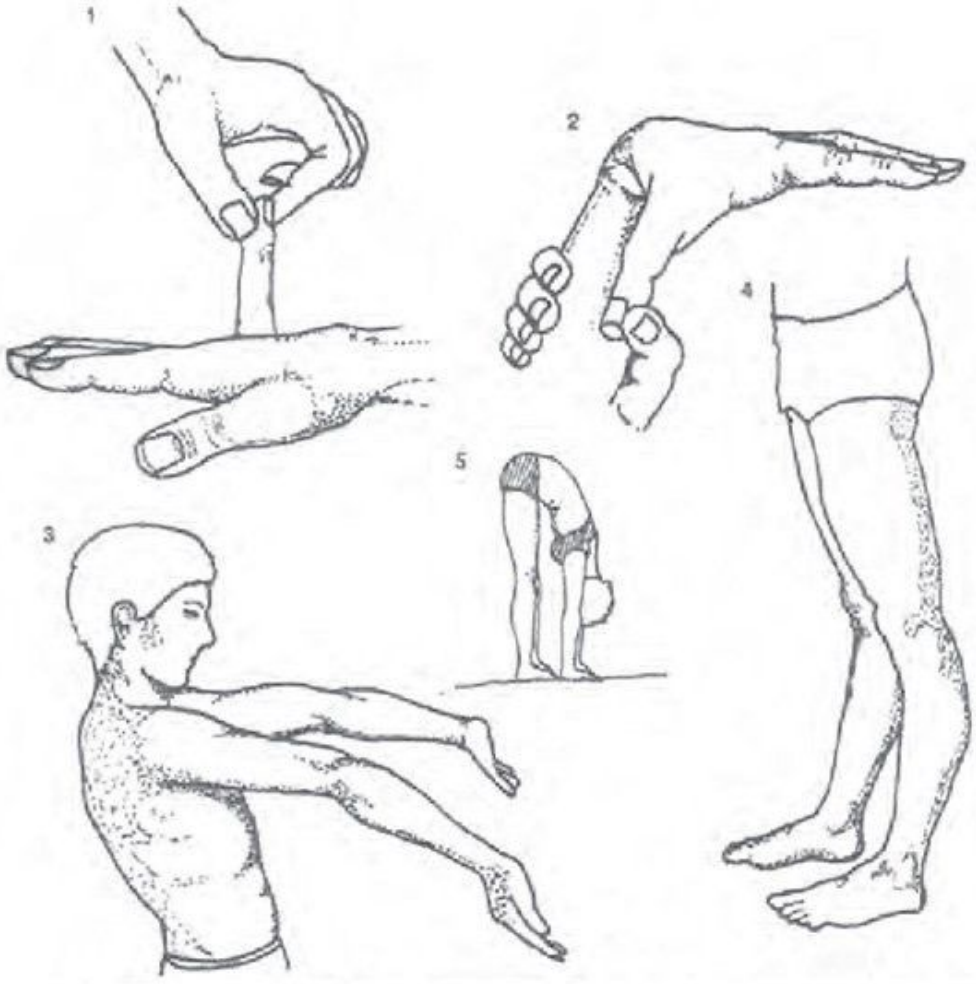
Причины ГЭРБ

1. Снижение тонуса нижнего пищеводного сфинктера

Нижний пищеводный сфинктер — главный клапан между пищеводом и желудком. В норме он открыт только во время глотания, а все остальное время плотно закрыт.
Если его тонус снижается, желудочное содержимое легче забрасывается в пищевод.

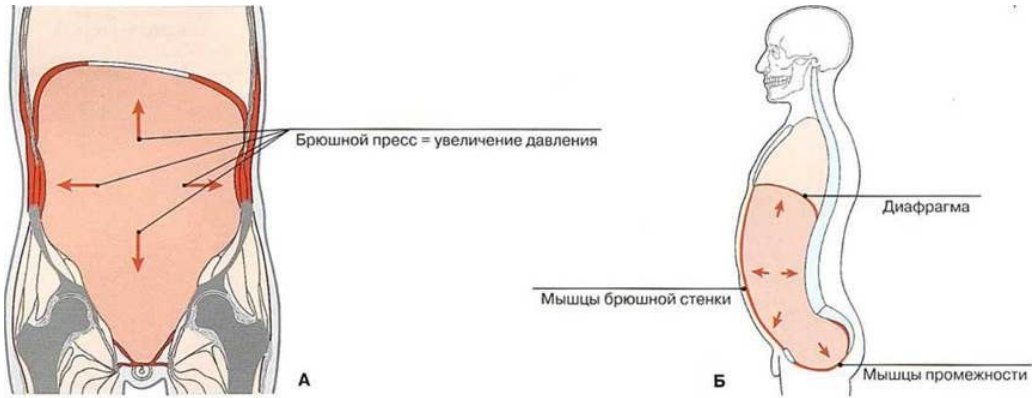
Причины снижения тонуса:

- *беременность;*
- *алкоголь и курение;*
- *кофеиносодержащие напитки: крепкий чай, кофе, энергетики, кока-кола*
- *снижение кислотности желудка;*
- *грыжа пищеводного отверстия диафрагмы;*
- *дисплазия соединительной ткани.*



HOLISTICA DOC

2. Значительное повышение внутрибрюшного давления



В норме внутрибрюшное давление выше, чем внутригрудное, однако обратному забросу содержимого желудка препятствует мощный антирефлюксный барьер. Но если давление в брюшной полости значительно возрастает - **возникает рефлюкс.**

Причины:

- беременность;
- тесная одежда;
- хроническое вздутие живота из-за СРК, СИБР, недостатка ферментов и др. причин;
- хронические запоры и частое натуживание;
- ожирение на животе;
- переедание;
- регулярная работа в наклонном положении;
- поднятие тяжестей;
- хронический кашель.



3. Нарушение моторики и секреторной функции ЖКТ

- замедленное опорожнение желудка, в.т.ч. из-за пониженной кислотности;
- нарушение координации работы желудка, двенадцатиперстной кишки и желчевыводящей системы.



В результате пища дольше задерживается в желудке, усиливаются процессы брожения и газообразования, повышается внутрижелудочное и внутрибрюшное давление, *возрастает вероятность заброса содержимого желудка в пищевод или заброса содержимого 12-перстной кишки в желудок и затем в пищевод.*

4. Ослабление защитных факторов слизистой ЖКТ

Слизистая пищевода постоянно контактирует с пищей, желудочным соком и микроорганизмами, поэтому имеет собственную систему защиты:
слой слизи, хорошее кровоснабжение, быстрое обновление клеток, достаточное слюноотделение и слаженную нервную регуляцию моторики и секреции.



4. Ослабление защитных факторов слизистой ЖКТ

Эффективность защиты может снижаться под влиянием факторов образа жизни:

- еда на бегу и плохое жевание (вырабатывается не достаточное количество слюны);
- хронический недосып;
- хр.стресс;
- дефицит белка, необходимого для обновления тканей;
- недостаточное потребление жиров, участвующих в синтезе гормонов и нормальном желчеотделении;
- нарушения пищеварения и плохого усвоения питательных веществ.

В результате слизистая медленнее восстанавливается, снижается ее устойчивость к действию кислоты, пепсина и желчных кислот, **а риск воспаления и повреждения пищевода возрастает.**

Факторы, усиливающие рефлюкс

Сами по себе они не всегда вызывают ГЭРБ, но способны значительно усиливать симптомы.

- быстрый прием пищи;
- плохое пережевывание;
- газированные напитки;
- кофе (у чувствительных людей);
- горизонтальное положение сразу после еды;
- интенсивная физическая нагрузка после приема пищи;
- хронический стресс.



Лекарства, которые могут усиливать ГЭРБ

- **Снижают тонус нижнего пищеводного сфинктера:** нитроглицерин, блокаторы кальциевых каналов (нифедипин, амлодипин, верапамил, дилтиазем), антихолинергические, седативные, препараты прогестерона (в.т.ч. некоторые КОК и препараты для гормональной терапии).
- **Замедляют опорожнение желудка: агонисты рецепторов GLP-1** (семаглутид, тирзепатид, лираглутид и др.), некоторые антидепрессанты с антихолинергическим действием.
- **Раздражают слизистую пищевода:** доксициклин и тетрациклин, препараты калия; железа.
- **Способствуют воспалению слизистой:** нестероидные противовоспалительные (ибупрофен, диклофенак, напроксен и др.), ацетилсалициловая кислота.

Диагностика ГЭРБ, функциональной изжоги и гиперчувствительного пищевода

1. Оценка симптомов
Кроме оценки жалоб (как по поводу пищевода, так и других - "масок"), полезно вести дневник симптомов, отмечая: когда возникают жалобы, после каких продуктов, связь с физической нагрузкой, положение тела, ночные симптомы.

2. ФГДС (гастроскопия)
Основной метод оценки состояния слизистой пищевода.
Позволяет выявить: воспаление и повреждение слизистой (эрозии, язвы), пищевод Барретта;
Гастроскопия не исключает ГЭРБ, так как у многих людей ГЭРБ есть без видимых изменений слизистой!

3. 24-часовая pH-импедансометрия
Это наиболее точный метод подтверждения ГЭРБ и дифференциальной диагностики гиперчувствительного пищевода и функциональной изжоги.
Позволяет определить: количество рефлюксов, их длительность, кислотность (кислые, слабокислые и некислые), жидкие и газовые рефлюксы, связь симптомов с эпизодами рефлюкса.

4. Рентгенография с контрастом
Позволяет выявить: грыжу пищеводного отверстия диафрагмы, стриктуры, нарушения прохождения пищи.

5. Биопсия слизистой пищевода: проводится при подозрении на пищевод Барретта, дисплазию или другие изменения слизистой.

Простой домашний тест ГЭРБ - альгинатный тест.

На фоне изжоги необходимо принять антацид (Гевискон), после чего изжога должна купироваться за 3-6 минут. Если изжога не пропала - это не ГЭРБ (может быть функциональная изжога, гиперчувствительный пищевод, кардиологические проблемы ...)



HOLISTICA DOC

Осложнения ГЭРБ

1. Эрозии и язвы пищевода
Могут сопровождаться болью, кровотечением и затруднением глотания.

2. Рубцевание и сужение пищевода
Основной симптом — постепенное затруднение прохождения пищи.

3. Пищевод Барретта
Состояние, при котором нормальная слизистая нижнего отдела пищевода постепенно замещается атипичным эпителием. Риск пищевода Баррета возрастает при длительно существующем рефлюксе, особенно если в нем присутствуют желчные кислоты! Нередко протекает бессимптомно и обнаруживается только при гастроскопии с биопсией!



HOLISTICA DOC

Осложнения ГЭРБ

4. Аденокарцинома пищевода
Развивается не сразу, а через последовательную цепочку изменений:
хронический рефлюкс → воспаление → пищевод Барретта → дисплазия → аденокарцинома.

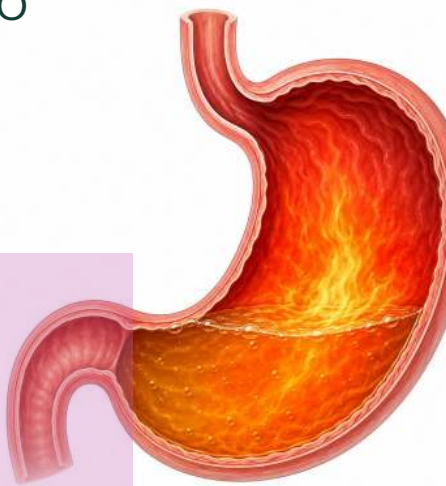
Именно поэтому длительно существующая ГЭРБ требует наблюдения и своевременного лечения!



HOLISTICA DOC

Как понять свой механизм развития изжоги?

ГЭРБ КАК ПРАВИЛО ВТОРИЧЕН ПО ОТНОШЕНИЮ К ДРУГИМ ПРОБЛЕМАМ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ. **ГЭРБ - ИХ СЛЕДСТВИЕ.**



У большинства людей изжога развивается не по одной причине, а сразу по нескольким. **Поэтому важно определить, какой механизм является ведущим именно у вас.**

Вялый тип пищеварения

- изжога на мучное, сладкое и жирное,
- поздняя изжога (через 30-60 минут после еды);
- частая отрыжка, без особого привкуса во рту;
- ощущение, что пища долго стоит в желудке;
- тяжесть после еды;
- частое вздутие (по типу дефицита ферментов желудка и поджелудочной и нарушения желчеоттока)
- лишний вес в области живота.



Что может быть:

Пища задерживается в желудке из-за низкой кислотности, слабой ферментной активности ЖКТ, замедленного опорожнения желудка. Внутрибрюшное давление усиливается из-за частого вздутия и абдоминального ожирения. Есть слабость нижнего пищеводного сфинктера.

Воспалённый тип пищеварения

- изжога на кислую, острую пищу;
- частая и продолжительная изжога;
- выраженное жжение;
- может быть боль в пищеводе;
- реакция на кофе, алкоголь;
- изжога и положении лежа и ночью.



Что может быть:
длительный контакт слизистой с кислым или смешанным рефлюктатом, воспаление слизистой пищевода, ГЭРБ, эрозивный эзофагит.

Чувствительный тип пищеварения

- изжога не постоянная, и быстро проходит;
- реакция на горький вкус - кофе, чай, какао, горький шоколад...
- усиливается на стрессе;
- изжога при наклонах;
- жалобы при нормальной гастроскопии;
- есть СРК, спастические запоры.



Что может быть:

гиперчувствительный пищевод; функциональная изжога; слабость обоих сфинктеров желудка, снижение защиты пищевода на фоне стресса.

Практический алгоритм оценки:

Если:
✔ много газов
✔ вздутие
→ **избыточное газообразование и повышение внутрикишечного давления.**
Возможные причины: запоры, нарушение переваривания углеводов, недостаток пищеварительных ферментов, СИБР и др.

Если:
✔ тяжесть после еды
✔ жирная пища переносится плохо
✔ длительное чувство переполнения желудка
→ **нарушение моторики желудка, недостаточное выделение желчи или пищеварительных ферментов.**

Практический алгоритм оценки:

Если:
✔ симптомы возникают после стресса
✔ изжога быстро возникает и быстро проходит
✔ гастроскопия без выраженных изменений
→ **повышенная чувствительность пищевода из-за хр. стресса.**

Если:
✔ хуже ночью
✔ хуже при наклонах
✔ хуже после переедания
→ **повышение внутрибрюшного давления, снижение тонуса нижнего пищеводного сфинктера / грыжа пищеводного отверстия диафрагмы.**

У большинства людей присутствует не один, а сразу несколько механизмов:

- слабый сфинктер + СИБР;
- нарушение моторики + стресс;
- запоры + желчный рефлюкс;
- ферментная недостаточность + гиперчувствительный пищевод.



Именно поэтому универсального лечения ГЭРБ не существует. Чтобы добиться стойкой ремиссии, важно определить **ведущий механизм**, а затем устранить факторы, которые поддерживают рефлюкс именно у вас.